

STEP 2 환자 교육

	무월경	월경통
공감	그 동안 월경이 불규칙하여 걱정도 되고 많이 놀라셨겠습니다.	그 동안 월경통이 심하여 걱정도 되고 많이 힘들었습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 여드름과 털이 많은 증상으로 미루어 보아 다낭난소증후군이 가장 의심됩니다.	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 월경과다와 함께 복부에 덩어리가 만져지는 것으로 미루어 보아 자궁근종이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 무월경에는 조기 폐경이나 정상 임신 등 다양한 원인이 있을 수 있습니다.	하지만 월경통을 일으키는 다른 질환으로 자궁섬근육종 등 다양한 질환이 있을 수 있습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 혈액검사, 골반초음파검사, 소변임신검사가 필요합니다. 괜찮으신가요?	따라서 정확한 진단을 위해서는 골반초음파검사, 자궁난관조영술, 골반 MRI가 필요합니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 검사 후에도 다낭난소증후군으로 진단이 되면 규칙적인 월경을 위해 경구피임약을 꾸준히 복용해 주셔야 합니다. 나중에 임신을 원하시게 될 경우 배란유도제를 복용하면 높은 확률로 임신이 가능하므로 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다.	만약 검사 후에도 자궁근종으로 진단이 되면 환자분께서 증상이 심하고 많은 불편을 호소하시기 때문에 수술이 필요할 수 있습니다. 수술 전 증상 호전을 위해서 단기간 약물 치료를 시행해 볼 수 있겠습니다.
예후	지금부터 꾸준히 치료를 받으시면 좋아지실 것입니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.	지금부터 치료를 받으시면 좋아지실 것입니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	[생활 습관 개선] 하지만 무엇보다 이 질환으로 인한 부작용을 줄이기 위해서는 체중 감량이 필수입니다. 조금이라도 몸무게를 빠시면 당뇨나 심혈관계 질환 등의 위험성을 줄일 수 있습니다. [약 복용법] 경구피임약 등을 복용하실 때에는 복용법에 맞게 복용하셔야 부작용으로 자궁 출혈이 생기지 않을 수 있습니다.	[응급] 생리량 과다로 호흡곤란 발생 시에는 수액 정주 등 응급 치료가 필요함을 설명 [정기 검진 권유] 별다른 문제가 없더라도 정기적으로 산부인과 검진을 받는 것을 권고드립니다.

교육	[과격한 운동 제한] 갑자기 과격한 운동을 시작하실 경우에도 월경 주기에 이상이 생길 수 있습니다. [정기 검진 권유] 별다른 문제가 없더라도 정기적으로 산부인과 검진을 받는 것을 권고드립니다.	
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?	

무월경

❖ 기본적 진단 계획

- ① Prolactinoma : 혈중 prolactin
- ② 쿠싱 증후군 : 24시간 소변 코티솔 농도, Dexamethasone suppression test
- ③ 갑상샘항진증 : 갑상샘 호르몬검사
- ④ 다낭난소증후군 : 골반초음파
- ⑤ 조기 폐경 : 혈중 FSH/LH

❖ 치료 계획

- ① Prolactinoma : bromocriptine, cabergoline
- ② 쿠싱 증후군 : 부신절제술, 경첩형동 샘종절제술
- ③ 갑상샘과다증 : 항갑상샘 약제
- ④ 다낭난소증후군 : 체중 감량, 임신 소망 시 클로미펜, 메트포민
- ⑤ 조기 폐경 : 호르몬 대체요법

❖ 진단 계획

- ① 원발 월경통 : 임상적 진단
- ② 자궁내막증 : 자궁난관조영술, 혈중 CA-125, 복강경 수술을 통한 조직학적 검사
- ③ 자궁근종 : 골반초음파, 자궁난관조영술
- ④ 자궁샘근육증 : 골반초음파

❖ 치료 계획

- ① 원발 월경통 : 진통제, 운동, 필요 시 경구피임제
- ② 자궁내막증 : 복강경 수술, 프로게스틴, 다나졸
- ③ 자궁근종 : GnRH agonist, 자궁근종절제술
- ④ 자궁샘근육증 : 임신 원할 경우 진통제, 피임제, 자궁 내 장치, 원하지 않으면 자궁 절제술

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 내분비적 문제가 의심되는 경우 혈중 호르몬검사가 필요하며, 약물 치료를 통해 교정이 가능함을 설명
- ② 스트레스나 과도한 운동에 의해서 발생하는 경우 자제시킬 것
- ③ 생리량 과다로 호흡곤란 발생 시에는 수액 정주 등 응급 치료가 필요함을 설명
- ④ 자궁 내 문제가 의심되는 경우는 질초음파를 시행하고, 약물 치료 및 필요 시 수술적 치료도 가능함을 설명



keyword

산과력과 월경력, 피임 방법 문진하기

무월경 : 임신, 내분비 이상, 속발성(PCOS, 조기 폐경)/원발성(터너중후군)

조기 폐경 : 의사-환자 관계에 신경써서 말하기

월경과다 교육 : 응급 상황 교육

공통 교육 : 정기적 산부인과 검진

시형 관련 코멘트



산전 진찰은 일반적 문진 알고리즘과는 다르게 산과적 과거력과 임신 증상, 임신 위험성 평가 등을 물어봐야 하지만 시간이 부족할 수 있으므로 문진을 적절한 비중으로 섞어서 진행해야 합니다.

정상 임신을 확인하러 온 임신 초기 산모도 있을 수 있고, 임신 도중 증상이 발생하여 온 환자도 있을 수 있습니다. 임신 초기의 산모일 경우에는 레오포드 모형을 착용하지 않고 있을 수 있지만, 후기 산모라면 모형을 착용하고 있을 가능성이 높으므로 모형 위에 복부 진찰을 시행하면 됩니다. 상담 파트와 유사하게 환자와의 rapport가 중요한 항목으로 환자의 정상 임신 가능성과 더불어 발생할 수 있는 유산 가능성에 대해 명확히 설명해야 하나 환자가 놀라지 않도록 부드럽게 표현해야 합니다. 문진도 중요하지만 환자 교육이 매우 중요하며, 양이 많으니 꼼꼼히 외워야 합니다. 산전 진찰 항목에는 정상 임신과 유산 외에도 임신 중 발생할 수 있는 여러 질환들에 대해 출제가 가능하기 때문에 임신 중 산모에게 발생할 수 있는 특이적 질환들과 위험 사항에 대해서도 숙지하고 있어야 합니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
산전 진찰	입덧 (emesis gravidarum)	[병력] 구역, 구토	[검사] 전해질검사(탈수 심할 때) [치료] 식습관 교정, 탈수 심하면 수액 치료
	고령 임신	[병력] 35세 이상의 고령, 산모	[검사] 선별검사 하지 않고 융모막용모 표본채취나 양수천자 [치료] 산전 관리 철저
	유산 (abortion)	[병력] 질출혈(절박유산 : 임신 전반기에 자궁 개대가 없는 상태에서 혈성 질분 비물 혹은 질출혈이 있는 경우)	[검사] 질초음파, 혈중 hCG 검사, serum FSH [치료] 절대 안정, 태아 죽어서 계류 유산 시 자궁소파수술

산전 진찰	임신 고혈압★ (gestational hypertension) /전자간증★ (preeclampsia)	[병력] 부종, 두통, 우측 상복부 통증, 시력 변화	[검사] 소변검사, 간기능검사, CBC [치료] Hydralazine, Labetalol, 황산 마그네슘, 필요 시 유도분만
	임신 당뇨병★ (gestational diabetes)	[병력] 소변검사에서 당이 나옴	[검사] 50g, 100g 경구당부하검사, 당화혈색소(HbA1c) 검사 [치료] 식이요법, 인슐린
	태반조기박리 (abruptio placentae) /전치태반 (placenta previa)	[병력] 과도한 질출혈+(복통 있으면 태반조기박리, 없으면 전치태반일 가능성 높음)	[검사] 질초음파, 복부초음파, CBC [치료] 수혈, 응급제왕절개수술
	조기 양막 파수 (premature rupture of membrane) /조기 산통 (preterm labor)	[병력] 질분비물 나옴/조기에 규칙적인 산통	[검사] 자궁경부검사, 니트라진검사, Nonstress test [치료] 절대 안정, 상황에 따라 출산, 글루코코르티코이드

기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

☞ 먼저 오늘 문진 내용은 제가 기록은 하지만 타인은 볼 수 없고, 비밀이 유지되므로 걱정하지 마시고 편하게 말씀하시면 됩니다. 몇 가지 질문해도 될까요?

O	임신반응검사를 언제 해보셨나요? → 소변검사 키트에서 두 줄이 확실히 보였는지 마지막 월경일이 언제였나요? (LMP) → 출산 예정일 말해주기 (월 - 3/+9, 일 + 7) (증상이 있어서 내원했다면) 언제부터 증상이 발생했나요?
L	-
D	-
Co	-

Ex	-
C = 여	[산모 평가] 산모의 키/체중/혈액형(아빠도)이 어떻게 되시나요? [월경력] 규칙적/주기/기간/월경량/ 경통은 있었나요? [산과력] 결혼하셨나요?/만-조-유-생 (몇 주에 유산/조산하셨나요?) 임기법 TPLA + 수유/출혈 [피임] 원하는 임신이신가요? or 피임을 하고 계셨나요?/어떤 방식으로? [주산기력] 이전 임신 시 산모 질환이 있었나요? 이전 출산에 문제가 있었나요? 혹시라도 이전에 분만하셨던 아이 중 유전병이나 선천 기형이 있는 아이가 있나요? [예방접종력] 예방접종은 다 맞으셨나요? (풍진, B형 간염 임신하기 3개월 전에 완료했어야 함)
A	[전신] 열/오한/체중 변화/피로 [유산/박리/파수] 질분비물/질출혈이 있었나요? → 색/양/통증 하복부 통증이 있나요? → 심해지는지/주기적인지/어디가 아픈지? [입덧] 메스꺼움/구토/속쓰림이 있나요? (N/V/H) [전자간증] 두통/시아장애/어지럼증/호흡곤란/거품노가 있나요? [갑상샘] 두근거림/더위불내성/체중 감소 [임신성 당뇨] 다음/다뇨/다갈/부종이 있나요? 임기법 임신부는 아이의 유입을 걱정해 담배 전갑을 당장 버렸다.
F	-
E	[건강 검진] 이전 건강 검진에서 자궁경부검사 같은 산부인과 검진도 받으셨나요? 이전 산전 진찰은 받으셨나요? → 얼마나 자주/왜 안했는지?
외	부인과 시술을 받으신 적 있나요? 최근 6개월 이내에 X-ray/CT를 촬영하신 적 있나요?
과	이전에 진단 받은 병이 있나요? → HTN, DM, 갑상샘, 알레르기, 뇌전증 성병(매독, 임질, 에이즈)/성교통
약	현재 복용하시는 약물이 있나요? → 경구피임약, 엽산 : 임신 2달 전 ~임신 4개월/철분 : 20주 이후
사	술, 담배, 커피는 하시나요? 직업이 어떻게 되시나요? → 어린아이를 돌보는지? 외국 여행을 다녀오셨나요?/동물을 키우시나요?

가	가족 중에 선천성 기형이나 유전 질환을 가지신 분 계신가요?
여	-
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [앉아서] 1. 눈 : 결막, 공막 + 전자간증이 의심되는 경우 시야검사 2. 입 : 구강 점막 3. 목 : 갑상샘 촉진 4. 복부 진찰★ : 시-청-타-촉 5. 사지 : 하지 부종, 피부 긴장도
술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 산부인과 진찰 : 정상 분만 진행 단계 진찰 - 레오폴드 수기로 태아의 위치 파악 - 도플러 초음파로 태아의 심박수 확인 - 골반 내진을 통해 질과 자궁의 구조적인 이상, 통증, 분비물 평가 - 골반 내진을 통해 effacement, dilatation, presentation, station, position, rupture of membrane 등을 파악 2. 산부인과 진찰 : 자궁경부파이버검사, 질분비물검사 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	임신 중에 000한 증상이 있으셔서 걱정이 되셨겠습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 혈압이 높으시고 000한 소견이 있어 전자간증이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 그 외에도 임신 00주에는 여러 질환에 의해 문제가 발생할 수 있습니다.
검사	따라서 전체혈구검사, 소변검사, 항체검사, 젖은경부도말검사, 질초음파를 하도록 하겠습니다.

치료	만약 검사로 전자간증으로 진단이 되면 혈압 조절을 위한 약물 치료가 필요할 수 있습니다.
예후	산전 진찰은 28주까지는 4주에 한 번씩 (36주까지는 2주/37주부터는 매주)
교육	[식이] 초기에는 입덧이 심할 수 있으니 조금씩 여러 번 드세요. 심하면 수액을 맞으러 오세요. 엽산제 → 임신 전부터 임신 초기까지 복용합니다. 300μg 씩 드세요. 철분제 → 임신 20주부터 드세요. 하루 7mg 씩 드세요. [응급] 질출혈/질액체/지속되는 두통/흐린 시력/열/오한/복통/태동 강도나 빈도 저하 시 바로 오셔야 합니다. [입원] 전자간증은 태아와 산모에게 매우 위험할 수 있는 병으로 현재 두통과 복통, 시야장애가 있으므로 검사 후 바로 분만이 필요할 수도 있습니다. 따라서 검사 후에 바로 입원을 도와드릴텐데, 어떻게 생각하시나요? 입원을 한 뒤 아이의 상태를 면밀히 관찰하도록 하겠습니다.
	임신 시 약물 복용에 주의해야 하므로 꼭 저와 상담하시고 약물을 복용하세요. 음주, 흡연은 금기입니다. 속옷에 묻는 정도의 질출혈/경미한 하복부 통증은 있을 수 있으나 심하고 지속되면 꼭 저와 상의하세요. 평소에 하던 운동이라면 계속하셔도 됩니다(심장병, 위축성 폐질환, IIOC는 No).
	5개월 정도에 태아의 청각이 완성되므로 태교가 도움이 됩니다. 아기에게 끊임없이 말을 걸고 교감을 나누세요.
	목욕 시에 미끄러지지 않게 조심하세요. 임신 36주까지는 여행할 수 있으나 장시간 앉아 있는 경우 1시간마다 쉬세요. 부담스런 중노동은 피하고, 노동 기간 중 적절히 쉬세요. 요통 발생 시 쏘그려 앉으시고, 앉을 때는 베개를 허리에 지지하세요. 굽이 높은 신발은 신지마세요.
	[상담] 예방접종 전 의사와 상담해 주세요. 임신 시 정상적으로 소변에서 당이 검출될 수 있지만, 추적 관찰이 필요하니 정기적으로 병원 내원해 주세요.
질문	다음 진료는 0주 뒤에 하도록 하겠습니다. 마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적인 진단 계획

- 소변검사/혈청 hCG 측정/질분비물검사, 질식초음파검사/혈액검사(Hb, Hct, Glucose, Electrolyte), TFT

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① hCG 증가가 반드시 임신을 의미하는 것은 아님을 설명
- ② LMP 확인해 출산 예정일 알려주기
- ③ 식이 습관 교정 : 하루에 300kcal 더 먹기, 임신 기간 중에 총 10~12kg 정도 증량이 필요하나 급격한 체중 변화는 피함
- ④ 엽산/철분제 복용, 임신 중 예방접종 피하기, 금주/금연, 방사선 노출 금지
- ⑤ 임신 후 첫 방문 시 해야 하는 검사에 대해 설명
- ⑥ 임신 시 정상적으로 요당이 검출될 수 있음을 설명, 추가검사 필요함을 설명 (갑상샘 호르몬검사도 마찬가지)
- ⑦ 복통, 질출혈 등 위험 증상 있는 경우 내원
- ⑧ 28주까지는 4주마다, 26주까지는 2주마다, 그 후에는 1주마다 검사
- ⑨ **절박유산 의심 시 절대 안정화하고 태아가 반드시 죽은 것은 아님을 설명하고 위로하기**
- ⑩ **임신 후반 6개월 동안 1kg 단백질 보충 필요(하루 5~6g)**
- ⑪ 몹시 피로하거나 임신에 영향을 줄 정도가 아니라면 운동이나 직장 생활을 제한할 필요는 없다.
- ⑫ 임신 중 배변 습관의 변화가 있음을 교육하고 적절한 식이와 운동이 필요함을 교육
- ⑬ 부부 관계는 분만 전 4주~분만 후 2주까지는 금육하도록
- ⑭ 임신 중 생백신 예방접종 절대 금기(MMR, Varicella, Polio PO 등)



keyword

임신 확인 및 LMP로 분만 예정일 알려주기

월경력, 산과력, 피임 여부, 주산기력(이전 임신/출산), 예방접종력(MMR, HBV)

증상이 있으면 집중적으로 문진하기

약물 : 철분제(20주 이후), 엽산(임신 1분기까지)

술기 : 레오폴드 수기, 골반 내진

정기적 내원 교육 : 28주까지 4주, 36주까지 2주, 37주부터 매주 방문 / 고위험 산모는 입원

생활 습관 교육 : 술/담배/커피 피하고 단백질 등 영양 보충 필요함 설명

응급 상황 교육(출혈, 전자간증, 감염, 진통, 태동 변화)

◎ 임신 주수에 따른 산전검사

주수	검사
처음 방문	위험 평가/분만 예정일 측정 P/Ex : 결막, 공막, 갑상샘, 유방, 하지 부종, 골반 내진 검사 : CBC(Hb, Hct), 소변검사, 소변 배양, 혈액형(ABO, Rh), Ab screen Rubella status, Syphilis screen, Pap smear, HbsAg test, HIV screen Cystic fibrosis screen 산모 교육
8~18주	초음파(8주부터 시작) → 태아 목덜미 투명대 측정(11~14주) 유전 질환 검사 - Chorionic villus sampling(10~12주) 융모막 융모 표본 채취 - Amniocentesis(양막천자) → 16~18주 - Cordocentesis(탯줄천자) → 20주 이후
16~18주	MS aFP
24~28주	당뇨병 선별검사(50g OGTT)/Hb, Hct
28주	Rh-negative 부모에게 다시 Ab 검사해서 D immune globulin 예방적으로 투여
32~36주	초음파, STD검사, Hb, Hct
매 방문 시마다	혈압, 몸무게, 자궁 크기, 수축 정도, 태아 심박수, 태아 움직임, 출혈 및 양막 파열 유무